

DESARROLLO DE RECURSOS DE CUIDADOS AVANZADOS

METODOLOGÍA NEWCARE

CONCEPTOS GENERALES

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS









NEW HEALTH EN LATINOAMÉRICA

- 12 años de vida.
- 50.000 pacientes al año atendidos en Programas excelentes de Cuidados Paliativos y de Cuidados Avanzados, bajo las metodologías NEWPALEX® y NEWCARE® .
- Presentes en 13 países de Latinoamérica, Europa y EEUU.
- Metodologías implantadas en 20 grupos aseguradores de salud y en más de 100 prestadores sanitarios.
- Sistema de gestión para Cuidados Paliativos y para Atención a la Cronicidad Compleja.
- Comunidades Compasivas: más de 6000 personas sensibilizadas y 2200 formadas al año.
- Más de 50 publicaciones científicas en Cuidados Paliativos, Cronicidad, Atención Integrada y Comunidades Compasivas.

NEW HEALTH: ECOSISTEMA INTEGRADO DE CUIDADOS

NEW HEALTH FOUNDATION | TODOS CONTIGO PROGRAMA DE COMUNIDADES COMPASIVAS

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWPALEX SISTEMA DE EXCELENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

SANITARIO

Programas de Cuidados Paliativos NEWPALEX



Programas de Sensibilización social y red de apoyo TODOS CONTIGO





Programas de Cronicidad

COMUNIDAD

SOCIAL

CALIDAD SOCIAL Y SANITARIA
© 2018

SANITARIO

SOCIAL

TODOS CONTIGO
PROGRAMA DE COMUNIDADES COMPASIVAS

COMUNITARIO



MODELO DE ATENCIÓN INTEGRADA SOCIO SANITARIA Y COMUNITARIA

EL MODELO INADECUADO Y MÁS EXTENDIDO



EL MODELO CLÁSICO (AÚN INALCANZADO)

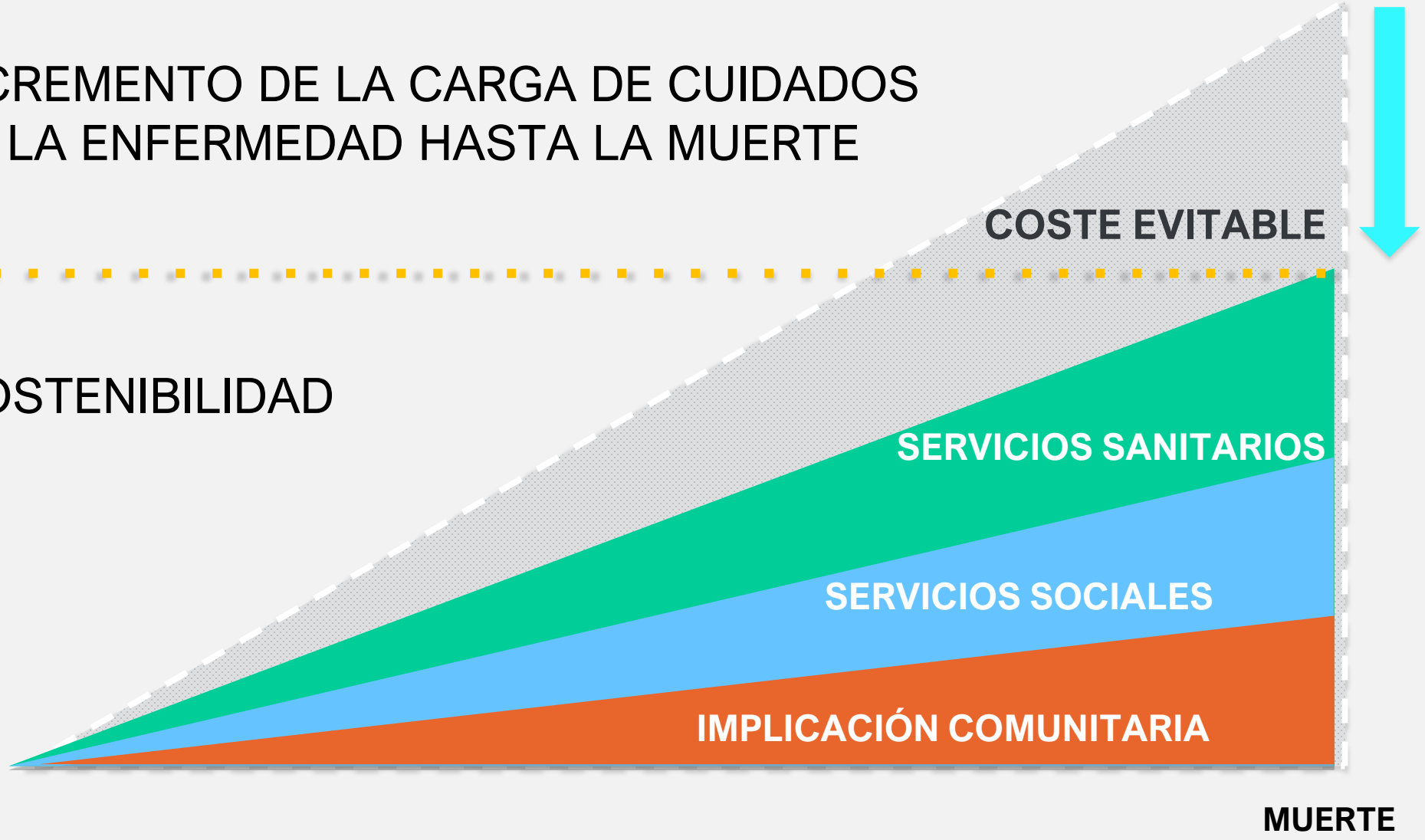


INCREMENTO DE LA CARGA DE CUIDADOS
EN LA ENFERMEDAD HASTA LA MUERTE

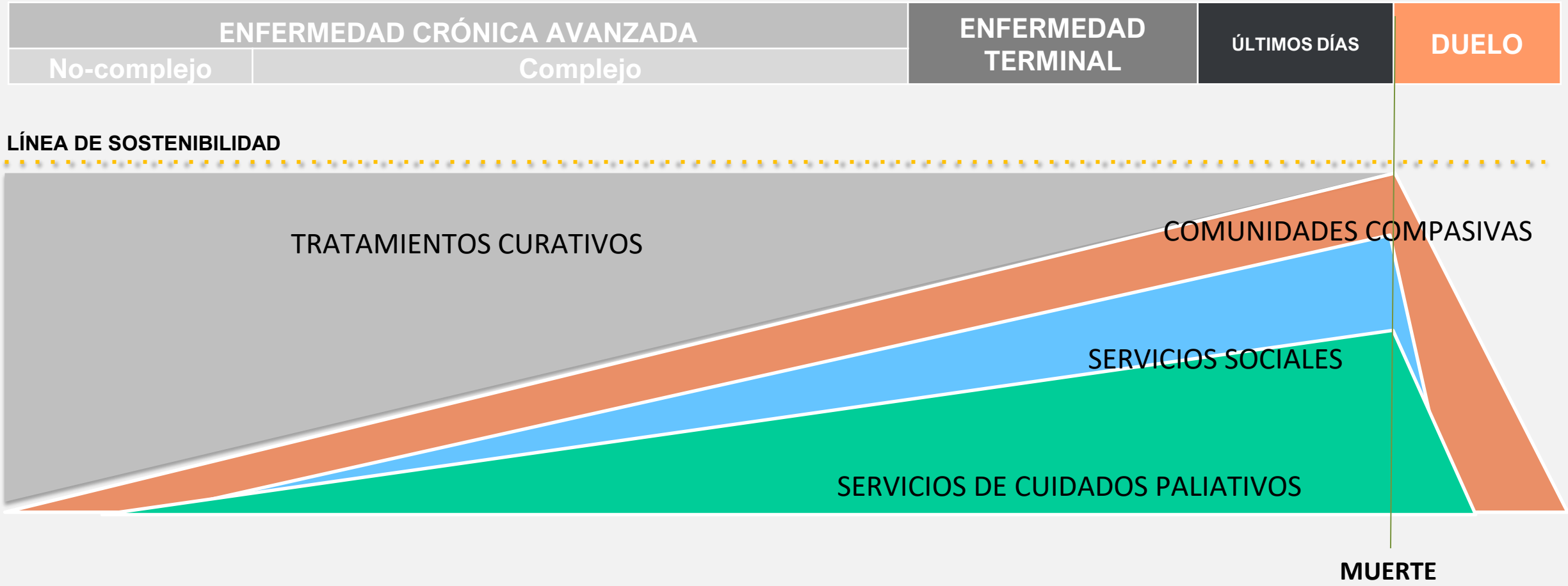
SOSTENIBILIDAD



INCREMENTO DE LA CARGA DE CUIDADOS EN LA ENFERMEDAD HASTA LA MUERTE



MODELO DE ATENCIÓN INTEGRADA DE NEW HEALTH





PROYECTO DEMOSTRACIÓN

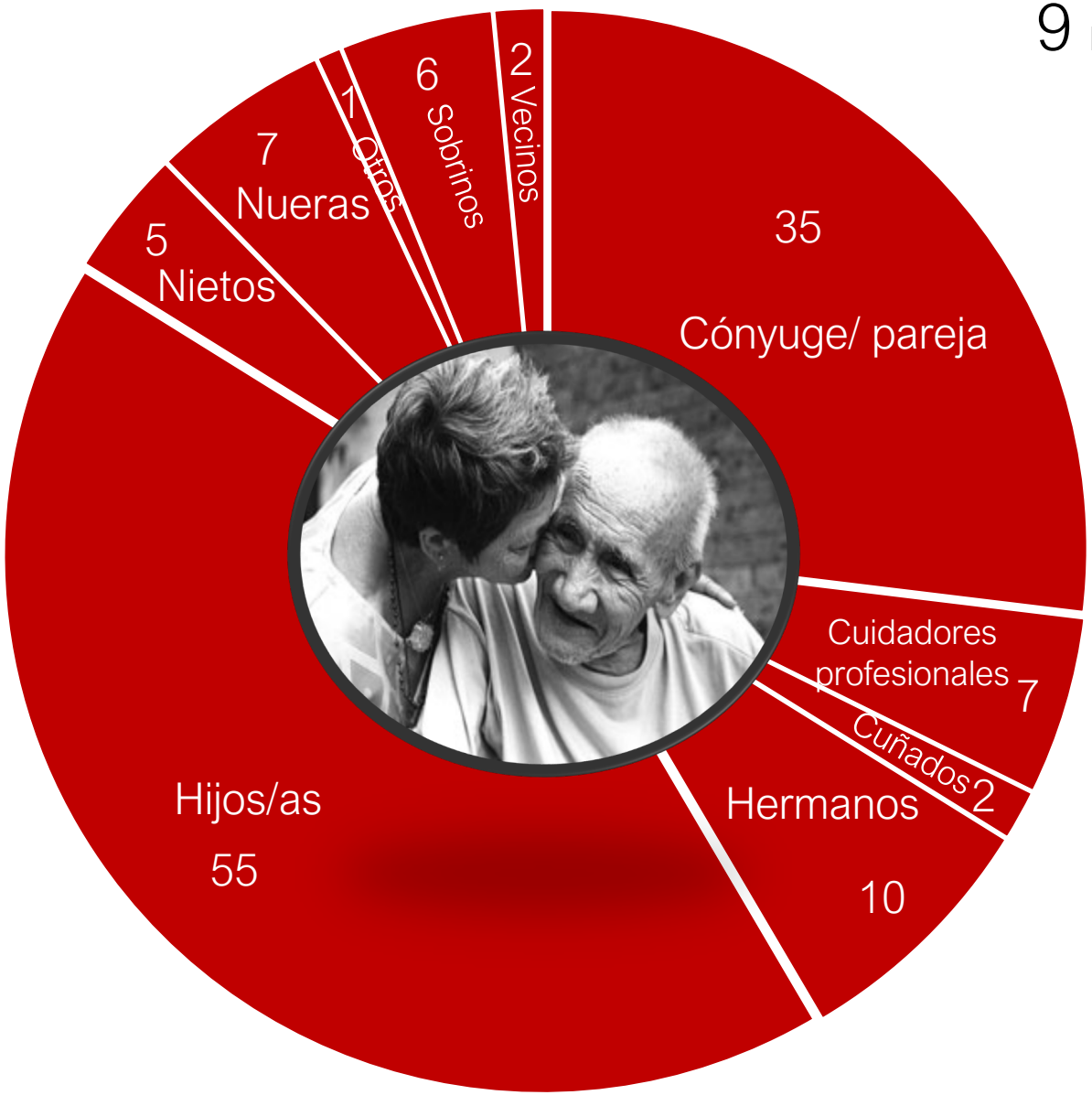
SEVILLA CONTIGO, CIUDAD COMPASIVA

Comienzo en 2015

© 2018

RESULTADOS

Los pacientes al final de la vida disponen a su alrededor de una media de **1 cuidador principal** que habitualmente actúa como principal interlocutor y se dedica principalmente a atender a las necesidades relacionadas con las actividades básicas de la vida diaria: lavado, comida, etc.



9 Personas que acompañan y cuidan

N= 99 personas.
Media edad: 72 años.
52% Hombres
89% Oncológicos.
Karnosfky: 50 (Requiere ayuda considerable de otros y cuidados especiales frecuente).

Interlocutores principales

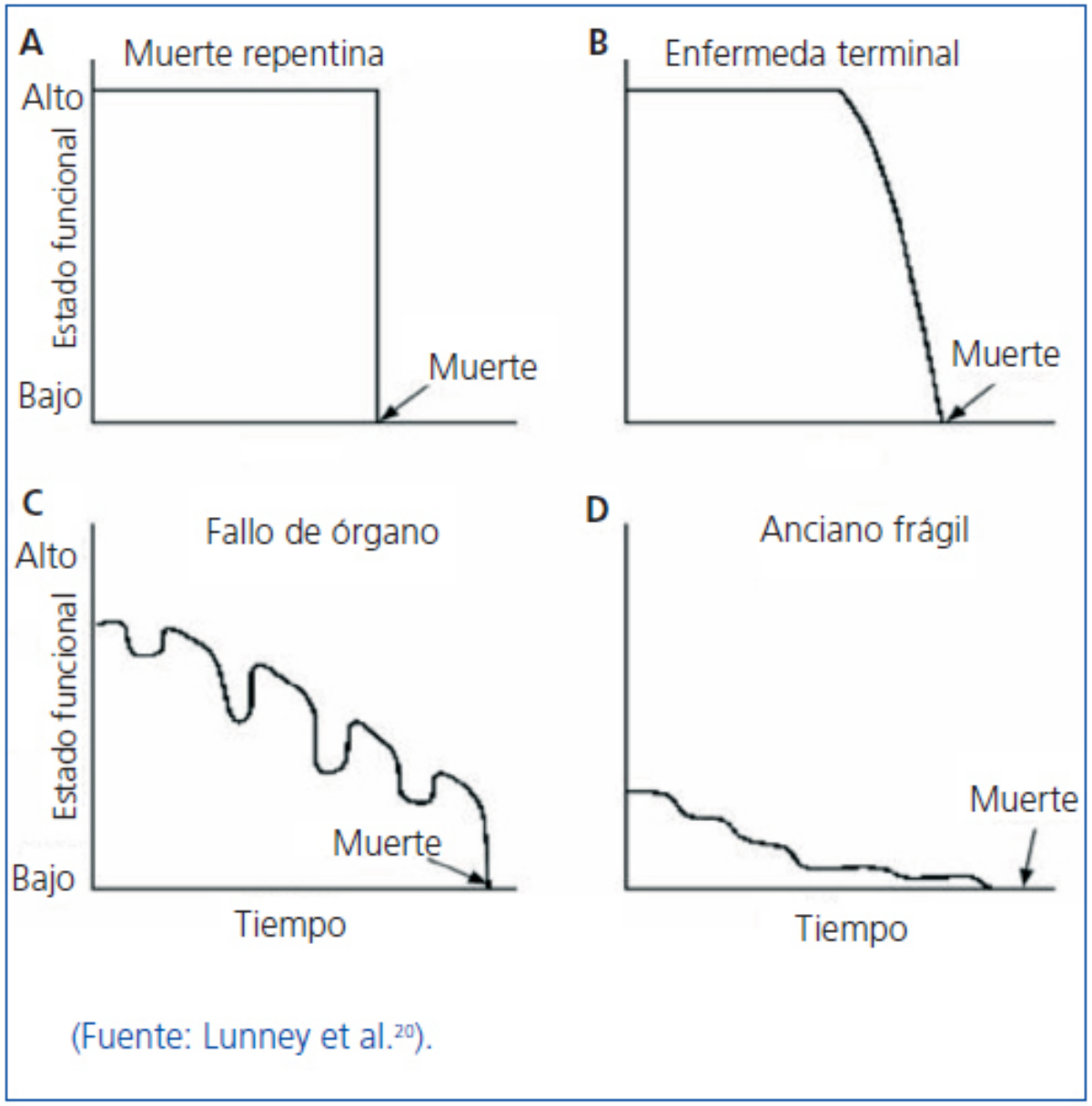
NEW HEALTH FOUNDATION

CALIDAD SOCIAL Y SANITARIA
© 2018



BASE CONCEPTUAL DE LA METODOLOGÍA NEWCARE

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS



(Fuente: Lunney et al.[20]).

Esta evolución de la enfermedades, permite establecer los tres grandes grupos de ISO-NECESIDAD (gestión y atención integral e integrada agrupable porque responde a necesidades similares del paciente y de la familia).

- Enfermedades neurológicas (Demencias y enfermedades neurodegenerativas)
- Cáncer
- **Insuficiencias orgánicas (respiratoria, cardiovascular, renal y hepática): IOCC**

1. Evitación descompensaciones.
2. Atención proactiva.
3. Mejora del cuidado.

Visión de atención integrada de servicios

PROGRAMA NEWCARE: La verdadera extensión de los programas de atención integrada hacia los procesos de enfermedad crónica y alta dependencia.



Atención Integrada

Principio organizador de la provisión de servicios con el objeto de mejorar la atención a las personas mediante la integración, coordinación o conexión de los servicios prestados.

Integración

Conjunto coherente de métodos y modelos en las funciones de financiación, gestión, organización, provisión de servicios y nivel clínico, diseñados para crear conectividad, alineamiento y colaboración entre los sectores del **curar y cuidar.**

¿Cómo definirían las personas usuarias una verdadera atención integrada?

“atención integrada es que yo sepa a quién tengo que llamar en cada situación y a quién me está atendiendo en cada momento, a que no tenga que contar mi caso varias veces a cada profesional que me atiende…”.

Proceso Asistencial Integrado de Ataque Cerebrovascular, 2002.

Calidad en el Modelo:
Efectividad
Satisfacción
Eficiencia



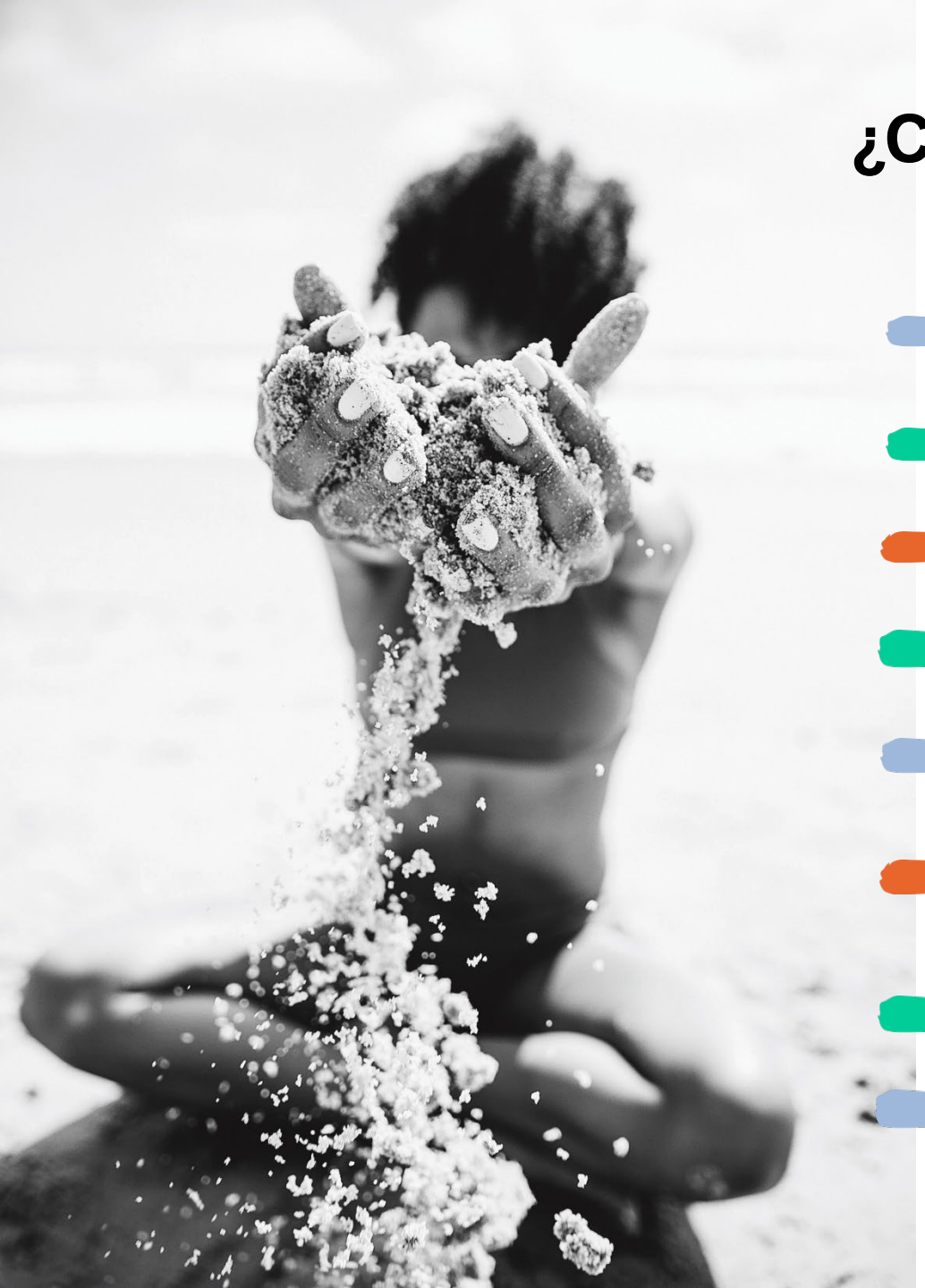


Compasión como eje transversal









¿CÓMO CONSEGUIR NUESTRO OBJETIVO?

- Atención centrada en la persona y sus necesidades.
- Planificación en base a una cartera de servicios integrada.
- Implicación de los profesionales para rediseñar el sistema.
- Enfoque intervención de factores de riesgo sanitario y social.
- Promoción de la continuidad asistencial internivel.
- Despliegue de Rutas de atención, Guías de Práctica Clínica y protocolos de actuación, basadas en la evidencia.
- Sistema de información integrado sanitario y social.
- Sistema de evaluación y análisis de impacto compartido.



NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

MÉTODO NEWCARE

¿QUÉ ES EL MÉTODO NEWCARE?

Método integral basado en los Sistemas de Gestión que permite alcanzar la Excelencia de Atención a Pacientes con Enfermedad Crónica de Mediana y Alta <Complejidad (IOCC), implicando **tanto a la Organización como a los profesionales y a la Comunidad.**



IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS

1. Cáncer.
2. Insuficiencias Orgánicas (25%-40%):
    a. Insuficiencia Cardíaca.
    b. Insuficiencia Respiratoria.
    c. Insuficiencia Hepática.
    d. Insuficiencia Renal.
3. Enfermedades Neurológicas:
    a. Demencias.
    b. Enfermedades Neurológicas Degenerativas.

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS

Riesgo de cronicidad compleja basado en:

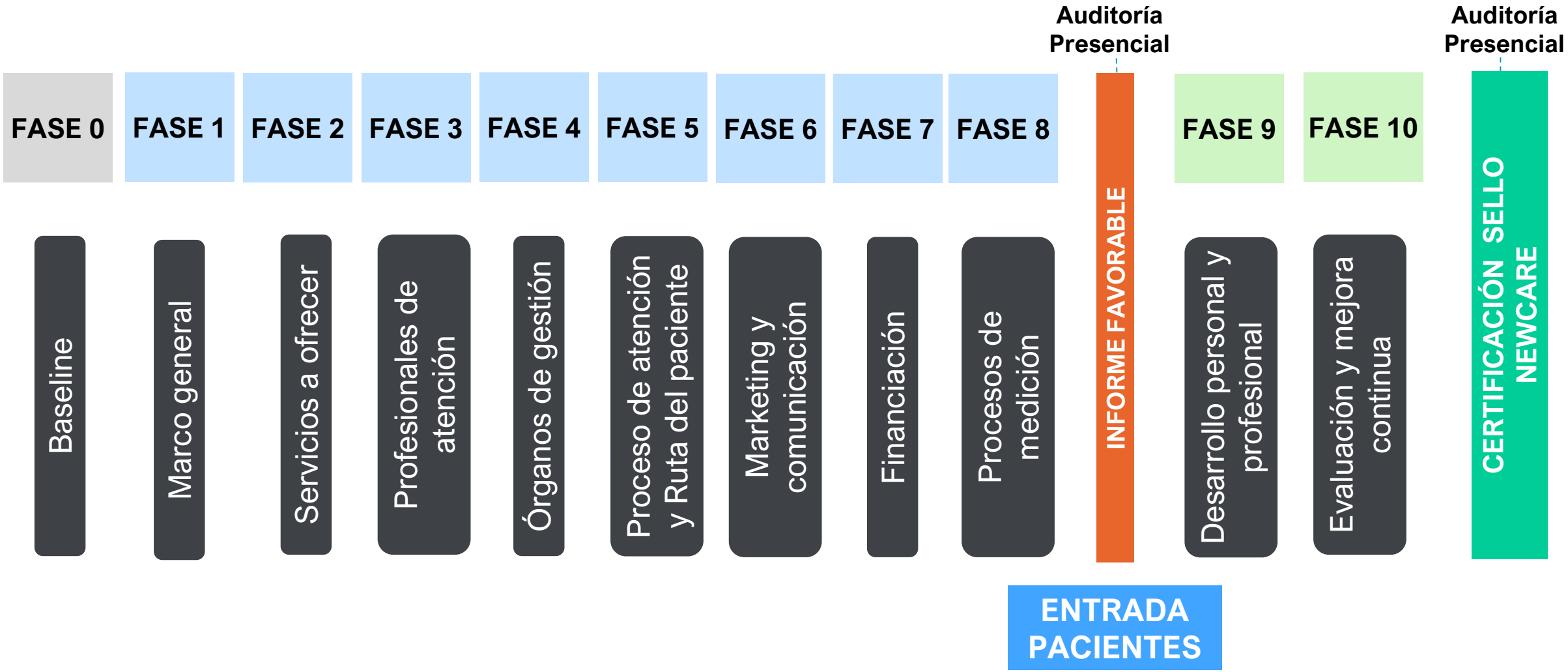
- Índice de complejidad teórico, el cual analiza:
    - Ingresos hospitalarios en el último año.
    - Visitas a urgencias.
    - Estado funcional del afiliado.
    - Estado cognitivo del afiliado.
    - Situación social del afiliado.
- Comorbilidad: 1, 2, 3, 4 o más de 4 patologías presentes en el afiliado.

Según los valores obtenidos en el índice de complejidad teórico, se considerará al paciente de Baja complejidad, Media complejidad o Alta complejidad.

OBJETIVO


CUADRUPLE AIM
MEJORA EN SALUD (Paciente)
MEJORA EXPERIENCIA DEL CUIDADO (Pacientes y familiares)
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
MAYOR SATISFACCIÓN PROFESIONALES
MAYOR EFECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

Fases del método NEWCARE



MÉTODO NEWCARE PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS

0. MARCO TEÓRICO	0.1. Descripción de la entidad	
	0.2. Organigrama general de la entidad	
	0.3. Misión, visión y valores	
1. MARCO GENERAL DEL RECURSO DE CRÓNICOS COMPLEJOS	1.1. Fundamentación de la creación	
	1.2. Análisis DAFO	
	1.3. Misión, visión, valores del Recurso	
	1.4. Objetivos	1.4.1. Objetivos generales
		1.4.2. Objetivos específicos
	1.5. Alcance	1.5.1. Patologías que se incluyen
		1.5.2. Nivel asistencial y lugar de atención
		1.5.3. Cobertura geográfica y poblacional
		1.5.4. Instalaciones y equipamentos
2. SERVICIOS A OFRECER	2.1. Servicios ámbito sanitario	
	2.2. Servicios ámbito social	
	2.3. Servicios ámbito comunitario	
	2.4. Medicamentos: gestión y almacenamiento	

MÉTODO NEWCARE PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS

3. PROFESIONALES DE ATENCIÓN	3.1. Estructura organizativa: organigrama del recurso	
	3.2. Procesos de selección y contratación	
	3.3. Equipo de atención e identificación del líder	
	3.4. Funciones del equipo de atención	
4. ÓRGANOS DE GESTIÓN	4.1. Asamblea de pacientes	
	4.2. Comición Socio Sanitaria Comunitaria / Junta de Cronicidad Clínica	
	4.3. Junta de Cronocidad Administrativa	
	4.4. Gestión interna del equipo	
5. PROCESO DE ATENCIÓN Y RUTA DEL PACIENTE	5.1. Identificación de pacientes susceptibles	5.1.1. Identificación a través de los Sistemas de Información
		5.1.2. Gestión para la identificación directa
		5.1.3. otras vías de identificación
	5.2. Gestión de la valoración multidimensional	5.2.1. Protocolo de valoración multidimensional
		5.2.2. Dimensiones, profesionales y escalas
	5.3. Criterios	5.3.1. Criterios de ingreso en función de la complejidad
		5.3.2. Criterios de derivación
		5.3.3. Agudizaciones
		5.3.4. Criterios de alta
	5.4. Procedimientos y protocolos	5.4.1. Plan de acción individualizado
		5.4.2. Protocolos
		5.4.3. Transición a programa de paliativos
	5.5. Herramientas de control y seguimiento	5.5.1. Agenda y citaciones
		5.5.2. Historia clínica
		5.5.3. Herramientas tecnológicas para la asistencia
		5.5.4. Herramientas de seguimiento de pacientes (modelo pizarra)
	5.6. Definición de la ruta y flujograma	

MÉTODO NEWCARE PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS

6. MARKETING Y COMUNICACIÓN	6.1. Plan de marketing y comunicación	
	6.2. Elementos de marketing y comunicación	
7. FINANCIACIÓN	7.1. Modelos de contratación	
	7.2. Gestión económica	
8. PROCESO DE MEDICIÓN	8.1. Listado de registros a generar	
	8.2. Tablero de indicadores	8.2.1. Indicadores de mejora de salud
		8.2.2. Indicadores de mejora en la experiencia del cuidado del paciente y la familia
		8.2.3. Indicadores de mejora en la satisfacción del profesional
		8.2.4. Indicadores de efectividad y sostenibilidad económica y organizativa
		8.2.5. Indicadores de control de la organización
9. DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL	9.1. Formación	9.1.1. Identificación de necesidades formativas
		9.1.2. Diseño del plan formativo
		9.1.3. Ejecución y evaluación
	9.2. Clima laboral y Burnout	9.2.1. Detección
		9.2.2. Plan de intervención general e individualizado
		9.2.3. Medidas preventivas
	9.3. Investigación	9.3.1. Definición de líneas de investigación
		9.3.2. Plan anual de investigación
		9.3.3. Resultados y publicaciones
10. EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA	10.1. Evaluación anual del recurso	
	10.2. Auditoría interna (si existe)	
	10.3. Revisión por la Dirección	
	10.4. Plan de mejora	

ALGUNAS SIMILITUDES NEWPALEX Y NEWCARE

- Atención Integral e Integrada.
- Enfoque sociosanitario y comunitario.
- Incluye a las áreas transversales.
- Modelo fundamentalmente domiciliario y ambulatorio.
- Consiguen mejora de la calidad de vida del paciente, mejor satisfacción del mismo y de los familiares, mayores ingresos para la prestación y ahorros para el asegurador.

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWPALEX
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS



NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

ALGUNAS SIMILITUDES NEWPALEX Y NEWCARE

- Rol fundamental de la familia y/o de los cuidadores.
- Incluye Promoción Comunitaria.
- Adaptado a cada entidad en base al Baseline inicial.
- Sistema de indicadores y registros obligatorios.
- Marco General de la Entidad.
- Priorización de Estación Clínica (Historia Clínica Digital).
- Importancia de la Comunicación con el entorno.

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWPALEX
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS



NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

ALGUNAS SIMILITUDES NEWPALEX Y NEWCARE

- Metodologías basadas en un Sistema de Gestión hacia la Mejora Continua.
- Incluyen Auditoría intermedia de Informe Favorable.
- Modelos Certificables.
- Orientados a la articulación con Programas.
- Incluyen asesoramiento para el desarrollo del Manual, y videoconferencias semanales de capacitación.

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWPALEX
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS



NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

ALGUNAS DIFERENCIAS NEWPALEX Y NEWCARE

- El periodo de estancia en el Programa.
- La Ruta del Paciente.
- Los Procedimientos y los Protocolos.
- El índice de Complejidad NEWCARE.
- Los Criterios de Inclusión.
- La Valoración del paciente.
- La interrelación con los especialistas.
- Las escalas y las herramientas a utilizar.

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWPALEX
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS



NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

ALGUNAS DIFERENCIAS NEWPALEX Y NEWCARE

- Los perfiles profesionales del equipo: médico internista (preferentemente) y/o geriatra, enfermero, auxiliar de enfermería y trabajador social. Opcional perfiles complementarios tales como psicólogo, nutricionista, fisioterapia, terapias específicas según la patología de origen, promotor comunitario (TS o no), teleasistencia, especialistas de las patologías, cuidador profesional...

NEW HEALTH FOUNDATION | NEWPALEX
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS



NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

ALGUNAS DIFERENCIAS NEWPALEX Y NEWCARE

- Coordinación con los Hospitales de referencia de cada patología.
- Articulación y derivación a Cuidados Paliativos.
- Juntas de Cronicidad.
- Asamblea de Pacientes.
- Comisiones Sociosanitarias y Comunitarias.
- Módulos de derivación de los sistemas de información.
- Acciones del Cuidador.

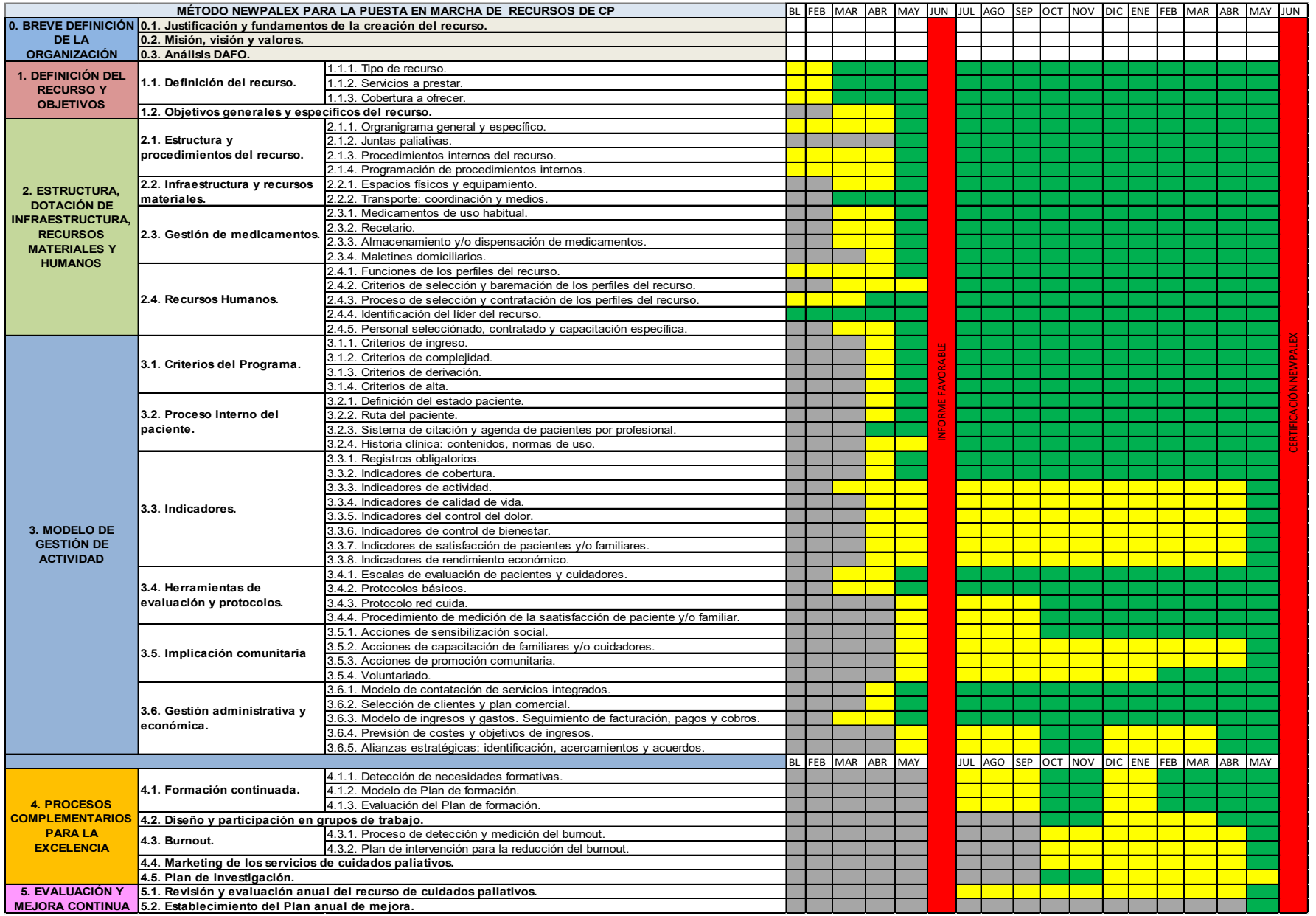
NEW HEALTH FOUNDATION | NEWPALEX
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CUIDADOS PALIATIVOS



NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE
SISTEMA DE EXCELENCIA DE CRÓNICOS

Seguimiento y control

- **VERDE**: si se cumple con los requerimientos para este parámetro.
- **AMARILLO**: si se cumplen parcialmente los requisitos y se está trabajando en dicho parámetro.
- **GRIS:** si no existe ni cumplimiento parcial del requisito del parámetro.





NEW HEALTH FOUNDATION | NEWCARE

PROPUESTA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN RECURSO DE CUIDADOS AVANZADOS EN OPTIMUS HEALTH.

[METODOLOGÍA NEWCARE]



MODELO DE TRABAJO.

El modelo de trabajo para el desarrollo del proyecto será mediante la formación y el acompañamiento a distancia, mediante videoconferencias establecidas periódicamente, para las fases de implementación del recurso y mediante auditorías presenciales para la emisión del Informe Favorable y de la Certificación.

Es decir, este modelo Incluye:

- Formación a distancia del método NEWCARE, apoyado por un procedimiento por procesos que permitirá guiar a la organización en cada una de las fases anteriormente descritas.

- Reunión presencial para proceso de auditoría para la verificación de procesos de implementación y emisión de informe favorable de la metodología.

- Acompañamiento a distancia mediante videoconferencia (semanal/ quincenal) para el coaching y seguimiento continuo de las acciones, revisión de documentación, formaciones, envío de herramientas (NEWCARE) de ayuda para el equipo, preparación para el proceso de certificación.

- Auditoría presencial para la certificación del recurso de Cuidados Avanzados y/o Cuidados Paliativos. Emisión del sello de Certificación NEWCARE.

MODELO DE TRABAJO.

Durante todo el proceso, el equipo de la organización tendrá a su disposición a los técnicos de New Health encargados del proceso en la entidad y podrá acceder a ellos continuamente a través del correo electrónico o los servicios de mensajería móvil instantánea, evitando en todo momento el retraso en el desarrollo de la implantación de la/s metodología/s por dudas o inquietudes que impidan el avance y que supongan el menoscabo del aprovechamiento de la siguiente videoconferencia planificada.

ELEMENTOS DE VALOR DE LA PROPUESTA.

La certificación NEWCARE otorgará a la organización:

- Un modelo de excelencia en la gestión y organización del recurso de cuidados avanzados y/o Cuidados Paliativos.
- Evaluación de los objetivos y mejora en los procesos definidos por la propia organización.
- Orientación a la organización hacia la mejora continua apoyada en un método testeado y en una certificación basada en la experiencia y en estándares internacionales.
- Cualificación de alto nivel de los profesionales en organización y gestión del recurso de cuidados avanzados. Capacitación del personal “learning by doing”.
- Reconocimiento de excelencia en la organización y gestión del recurso de cuidados avanzados.
- Prestigio y confianza frente a los profesionales y la población en general.
- Inclusión en los procesos de excelencia no solo de los pacientes sino también de los familiares y cuidadores, convirtiéndolos en eje fundamental del funcionamiento de los Métodos.
- Un ahorro de costes basado en la optimización de los recursos humanos, infraestructuras y dotaciones gracias al nuevo modelo.
- Actualización permanente de herramientas de evaluación de pacientes y familiares.
- Un aumento en la sensación de bienestar, calidad de vida y satisfacción de los propios pacientes.
- Participación en redes de voluntariado y conocimientos en desarrollo de acciones de sensibilización social.
- Difusión de la mejora continua experimentada, integrada en planes de marketing de la organización.

CRONOGRAMA

En la presente propuesta se plantea un calendario de 18 meses para conseguir la certificación NEWCARE a partir de las auditorías necesarias, pudiendo disminuir dicha duración en base a la capacidad de avance en el proceso de la organización (existiendo entidades que lo realizan en 12 meses) o bien pudiendo ser ampliada.

Sin embargo, hay que destacar aquí que el contrato es por la realización del proceso completo, independientemente del tiempo que la entidad requiera para alcanzarlo, siempre y cuando no se produzca una interrupción en el mismo.

A grandes rasgos el desglose aproximado sería:

- 6 meses para el desarrollo de los modelos teóricos de atención.
- 1 mes para la realización de la Auditoría y la emisión del Informe Favorable si procede de la Metodología.
- 1 mes para el inicio de la atención de pacientes y el comienzo del reajuste del modelo.
- 10 meses para desarrollar la segunda fase de la implantación de la metodología.

Pasados estos meses, la entidad debe estar preparada para la Auditoría de Certificación del método NEWCARE. A la finalización de cada uno de los periodos indicados, la entidad deberá entregar el Manual de Implantación de la metodología, el cual hará la labor de entregable, como demostración de haber alcanzado el hito marcado para esa fecha, y como herramienta de control del trabajo realizado.

COSTES.

El importe de los honorarios de las acciones de formación y acompañamiento (incluyendo las auditorías de Informe Favorable y Certificación) durante el periodo de duración del proyecto, es de 9.500€ (NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS NETOS) para la atención domiciliaria y hospitalaria de mediana complejidad del Programa de crónicos complejos (cuidados avanzados) en Optimus Health, para su sede de Sincelejo.

Este importe se abonaría en tres partes del siguiente modo:

a) Se abonarían TRES MIL QUINIENTOS EUROS NETOS (3.500 €) a la firma del contrato.
b) Se abonarían TRES MIL EUROS NETOS (3.000 €) antes de la realización de la auditoría de Informe Favorable del Método NEWCARE, para dar entrada a pacientes.
c) Se abonarían TRES MIL EUROS NETOS (3.000 €) antes de la realización de la auditoría de Certificación del Método NEWCARE.

Se incluyen en estos honorarios los gastos correspondientes a 2 viajes a Colombia y su manutención, a fin de cumplir con los objetivos del proyecto y la auditoría de Informe favorable y Certificación.

Los honorarios para la renovación del sello en su segundo y tercer año tendrían un coste total de DOS MIL EUROS NETOS (2.000 €) para cada año de renovación, e incluiría la auditoría de revisión, pudiendo decidir la entidad si desea realizarla cada dos años.



El privilegio de cuidar

NEW HEALTH FOUNDATION

info@newhealthfoundation.org
newhealthfoundation.org



+34 635 236 619
rafaeldoblado@newhealthfoundation.org
Calle Astronomía, 1. Torre 2. Planta 9.
Módulo 7.
41015. Sevilla. España
newhealthfoundation.org

